

Cơ thắt niệu đạo nhân tạo (AUS)

Thông tin cho bệnh nhân · Những điều cần biết trước khi phẫu thuật AUS

WARWIKI

Cơ thắt niệu đạo nhân tạo (AUS) là một thiết bị nhỏ đặt hoàn toàn dưới da, giúp khôi phục khả năng kiểm soát bàng quang khi bạn bị tiểu không kiểm soát — thường gặp sau phẫu thuật tuyến tiền liệt. Bạn tự điều khiển thiết bị bằng bơm đặt trong bìu. Tờ thông tin này giải thích cách hoạt động, cách chuẩn bị và những gì sẽ xảy ra.

Về ca phẫu thuật này

Tiểu rĩ khi hoạt động, ho, hoặc nhấc vật nặng gọi là **tiểu không kiểm soát khi gắng sức**, thường xảy ra sau phẫu thuật tuyến tiền liệt. AUS điều trị tình trạng này bằng ba bộ phận kết nối, đặt hoàn toàn dưới da:

- **Vòng bít** quanh niệu đạo (ống dẫn nước tiểu ra ngoài) bóp nhẹ để giữ cho bạn không bị rĩ nước tiểu
- **Bơm** trong bìu dùng để bóp khi muốn đi tiểu
- **Bình chứa** nhỏ ở bụng dưới duy trì áp suất phù hợp

Cách sử dụng: bình thường vòng bít đóng giữ cho bạn khô ráo. Khi cần đi tiểu, bóp và thả bơm vài lần — vòng bít mở ra và bạn đi tiểu. Vài phút sau vòng bít tự đóng lại.

Có an toàn không?

AUS là phương pháp điều trị tiêu chuẩn vàng lâu đời cho loại rĩ nước tiểu này, và hầu hết nam giới đạt được kiểm soát rất tốt. Như mọi thiết bị cấy ghép, có một số rủi ro — chủ yếu là nhiễm trùng, hoặc hao mòn thiết bị hay niệu đạo theo thời gian có thể cần sửa chữa sau này. Nhóm chăm sóc giảm nguy cơ nhiễm trùng bằng kháng sinh, kỹ thuật vô khuẩn và điều trị nhiễm trùng nước tiểu trước mổ.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Rĩ nước tiểu khi hoạt động, ho, hoặc nhấc vật nặng.

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể.

Vòng bít

Bộ phận bóp nhẹ niệu đạo để giữ cho bạn khô ráo.

Bơm

Bộ phận trong bìu bạn bóp để mở vòng bít và đi tiểu.

Kích hoạt

Bật thiết bị tại phòng khám khoảng 6 tuần sau mổ, khi vết thương đã lành.

Ngừng kích hoạt

Tắt thiết bị (giữ vòng bít mở) — cần thực hiện trước khi đặt ống thông.

Gây mê toàn thân

Thuốc giữ cho bạn ngủ sâu và không đau trong phẫu thuật.

Nội soi bàng quang

Kiểm tra niệu đạo và bàng quang bằng camera, thường thực hiện trước mổ.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật dưới gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống, nên bạn không cảm thấy gì khi mổ. Sau đó bìu và vùng đáy chậu sẽ đau, sưng và bầm khoảng 1–2 tuần — quần lót nâng đỡ, chườm lạnh và thuốc giảm đau sẽ giúp ích. Ca mổ kéo dài 1–2 giờ; nhiều người về nhà trong ngày.

Cách chuẩn bị (trước phẫu thuật)

- Phẫu thuật dưới **gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống** — tuân thủ mọi hướng dẫn (nhịn ăn, và các thuốc cần ngưng, kể cả thuốc làm loãng máu).
- **Xét nghiệm nước tiểu** kiểm tra nhiễm trùng — nếu có nhiễm trùng phải điều trị trước; lịch mổ có thể thay đổi nếu bạn đang bị nhiễm trùng.
- **Không hút thuốc hoặc dùng thuốc lá điện tử**; tắm bằng **xà phòng kháng khuẩn** được cung cấp và uống kháng sinh theo chỉ dẫn — phòng ngừa nhiễm trùng là ưu tiên hàng đầu.

Thông báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Đã từng **xạ trị** vùng chậu, hoặc đã phẫu thuật niệu đạo hay tiểu không kiểm soát trước đây
- Có **đái tháo đường**, hoặc khó dùng tay (vì bạn tự vận hành bơm)
- Có bất kỳ nhiễm trùng nào ở bất kỳ vị trí nào

Quá trình phẫu thuật

- 1 Bạn được gây mê hoặc tê từ thắt lưng trở xuống, và được dùng kháng sinh.
- 2 Qua các vết mổ nhỏ, bác sĩ phẫu thuật đặt **vòng bít** quanh niệu đạo, **bình chứa** ở bụng dưới, và **bơm** trong bìu — tất cả đều dưới da.
- 3 Thiết bị được bơm đầy và kiểm tra, sau đó **để ở trạng thái tắt** để vết thương lành.

Sau phẫu thuật

- Mặc quần lót nâng đỡ, chườm lạnh, và tránh **nhấc vật nặng, rặn, đạp xe và quan hệ tình dục** theo hướng dẫn của bác sĩ.
- **Thiết bị ở trạng thái TẮT khoảng 6 tuần.** Bạn vẫn còn rỉ nước tiểu và nên tiếp tục dùng miếng lót — đây là bình thường. **Không bóp bơm** cho đến khi bác sĩ kích hoạt thiết bị.
- Tại lần khám khoảng **6 tuần sau, bác sĩ sẽ kích hoạt thiết bị** và hướng dẫn bạn cách sử dụng bơm.
- **Luôn báo cho nhân viên y tế rằng bạn có AUS** — phải ngưng kích hoạt trước khi đặt bất kỳ ống thông nào, nếu không có thể tổn thương niệu đạo. Mang theo thẻ cảnh báo y tế.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt, ớn lạnh, hoặc vết mổ đỏ, đau hoặc chảy dịch ngày càng nhiều
- Đột ngột không thể đi tiểu được
- Bìu sưng to, cứng hoặc ngày càng đau hơn

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. AUS là thiết bị ẩn dưới da giúp khôi phục kiểm soát bàng quang — vòng bít giữ bạn khô ráo, bạn bóp bơm trong bìu để đi tiểu.
2. Thiết bị ở trạng thái TẮT khoảng 6 tuần (bạn vẫn còn rỉ — đó là bình thường), sau đó được kích hoạt và bạn được hướng dẫn cách dùng.
3. Phòng ngừa nhiễm trùng là quan trọng nhất: không hút thuốc, dùng xà phòng kháng khuẩn và kháng sinh. **Luôn báo cho nhân viên y tế rằng bạn có AUS — phải ngưng kích hoạt trước khi đặt ống thông.**